員郭醫療社團法人
員郭醫院

昕力資訊

個別化照護系統

院長報告

> 以數位整合促進跨專業協作，落實以病人為中心的復健照護



對象：主管機關　**報告人**：院長

時間：10 分鐘

本簡報資料皆為示範資料，系統目前為展示版

2026/10/14

數位整合跨專業資訊，推動個別化復健照護

改善復健資訊分散與紀錄格式不一的現況，建立團隊共同照護平台

1

資訊整合

整合不同職種的評估結果、
復健目標與照護資訊，
建立一致的數位化呈現方式

2

跨專業協作

以病人生活需求為核心，
促進團隊共同掌握
照護目標與復健進度。

3

個別化照護

依據個案功能狀態與生活目標，
制定及調整復健計畫，
支持功能恢復與返家準備。

從分散紀錄到數位整合，讓跨專業團隊共享資訊、協同照護。

為什麼需要

四個現況問題，四個系統作法

從「醫療人員單方訂定」改為「病人先說想要什麼」

現況問題	系統作法
復健目標由醫療人員單方訂定	由病人與家屬先選「生活願望」
各專業各自記錄，資料分散	一位病人一份主檔，各專業共用
計畫修訂沒有紀錄	每次修訂產生新版本，並留下原因與操作者
病人不知道自己進步多少	生活功能護照顯示 150 項任務的解鎖進度

六個階段：從入院到出院

入院 → 出院

① 建檔	② 認識病人	③ 選願望	④ 功能象限	⑤ 選任務	⑥ 計畫與追蹤
個案主檔 照護模式	跨專業共填 熟識人資料	28 張圖卡 病人自己選	重要 × 急迫 病人與家屬拖	150 項任務 與願望連結	長短期目標 版本追蹤
主角 **護理／行政**	主角 **八個專業**	主角 **病人與家屬**	主角 **病人與家屬**	主角 **治療師**	主角 **治療師與團隊**

生活功能解鎖護照

病人端：任務闖關＋願望與目標

出院成果（規劃）

前後比較　目標達成　已解鎖功能　後續建議

醫療團隊操作　病人與家屬操作

階段 ① 入院建檔

建立個案主檔

一位病人一份主檔，轉換照護模式不覆蓋舊資料

護理人員建檔
建立病人主檔

→

獨立系統 ID
一位病人
一個 ID

→

預留識別碼
病歷號・PAC・杏翔

四種照護模式 （病人可隨時轉換）

PAC
啟用計畫

↔

復健病房
啟用計畫

↔

一般復健
選用

↔

OPD
選用

轉換照護模式時新增一筆歷程，舊照護模式保留在歷程中，不覆蓋

入院到出院共有六種階段（第 4 頁），各流程階段的操作都寫入操作紀錄

階段 ①　系統畫面

個案主檔與照護模式歷程

變更照護模式時新增歷程，不覆蓋舊紀錄



① 個案主檔：基本資料、識別碼、照護模式歷程

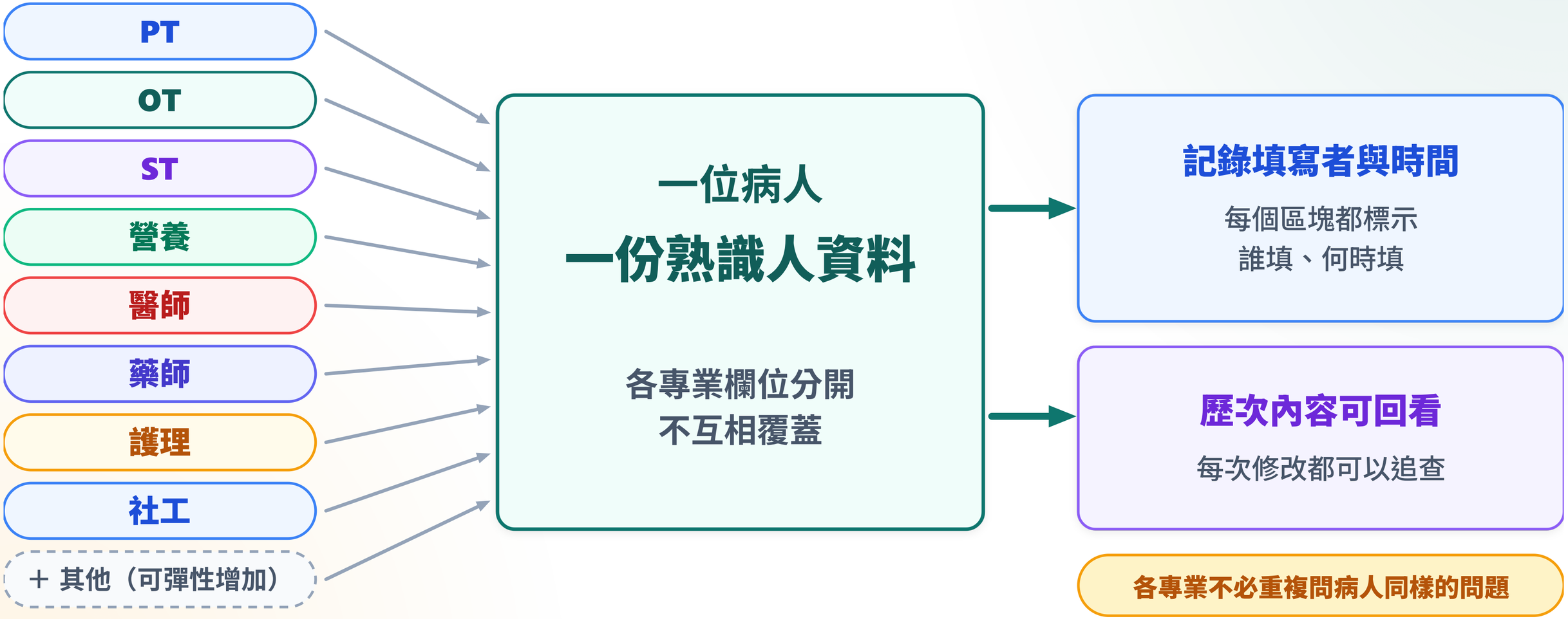


變更照護模式：新增歷程，不覆蓋舊紀錄

病人轉換照護模式時，系統新增一筆歷程，舊資料不覆蓋

熟識人資料：八個專業共填，可彈性增加

各專業不必重複問病人同樣的問題



階段 ② 系統畫面

熟識人：跨專業總覽

共同資料與各專業區塊並列，每區塊標示填寫者與時間



八個專業各填各的欄位；每次修改都留下填寫者與時間

28 張願望圖卡

先初選，再與治療師共同確認最終願望

初選

照 喝熱湯麵

照 夾小菜水果

照 開寶特瓶

居 泡茶煮水

社 圍爐聚餐

照 穿圓領上衣

照 扣襯衫排釦

照 穿長褲拉鍊

共 28 張圖卡

先初選，再與治療師確認最終願望

確認

預期目標

每張圖卡的第二層文字
就是「患者預期目標」

可新增自訂願望

圖卡沒有想要的，自己加

大圖、大字

長者也能自己操作

階段 ③　系統畫面

願望圖卡：大圖、大字

已加入初選的卡片以綠框標示；可看單張詳情



③ 願望圖卡：病人點選



願望詳情：預期目標與示範內容

病人用大圖、大字自己選，長者也能操作

生活功能象限：先做重要又急迫的事

由最終願望帶出生活功能項目，病人與家屬放入四個象限

最終願望

病人與家屬確認

↓

生活功能項目 ★

星等＝幾個願望共同需要

↓

放入象限

拖曳，或先點再按「放入 Q」

急迫性　高 → 低

Q3　急迫不重要

暫定：短期、可請照顧者協助

不倒翁的試煉 ★

Q1　重要且急迫

暫定：短期優先

黃金左手/右手 ★

吸管神射手 ★

Q4　不重要不急迫

暫定：暫緩，定期再評估

Q2　重要不急迫

暫定：長期目標

完美湯料理 ★

重要性　低 → 高

暫定短／長期僅供參考，最後由治療師逐項決定

生活功能象限：重要性 × 急迫性

星等代表願望交集，不代表能力或意願分數



Q1「重要且急迫」暫定短期優先，最後由治療師決定

一個願望，拆成多個生活任務

150 項任務，所有照護模式的病人都可以使用

願望：自己拿湯匙喝完一碗熱湯麵

食 → 黃金左手/右手 → 完美湯料理 → 吸管神射手

願望：拿著單拐在室內客廳平穩步行

行 → 不倒翁的試煉 → 拐杖/助行器密碼 → 走廊急先鋒 → 倒車雷達開關

一個願望，對應多個生活復健任務

150 項任務　六大領域

食　衣　住

行　育　樂

每個領域三級

銅 → 銀 → 金

一般復健／OPD：選完任務即可儲存

階段 ⑤　系統畫面

生活復健任務：150 項任務庫

每張任務卡標示銅、銀、金級與所屬階段



一個願望拆成多個任務；150 項任務所有照護模式共用

治療師訂出完整復健計畫

願望變成目標，目標變成每天的任務

預期目標
來自願望

→

長期目標
治療師訂定

→

短期目標
治療師訂定

→

任務分期
逐項決定
短期或長期

→

預後目標
預設片語
或 AI 草稿

每次修訂都留紀錄

v1 → v2 → v3

修訂原因必填，舊版保留，可比較差異

預後目標：AI 只產生草稿

AI 草稿 → 專業人員確認 → 存成新版本

專業人員修改確認後，才儲存

復健計畫：提醒與 AI 草稿

預期目標由願望帶入；預後目標可由 AI 產生草稿



檢討與修訂提醒、患者預期目標

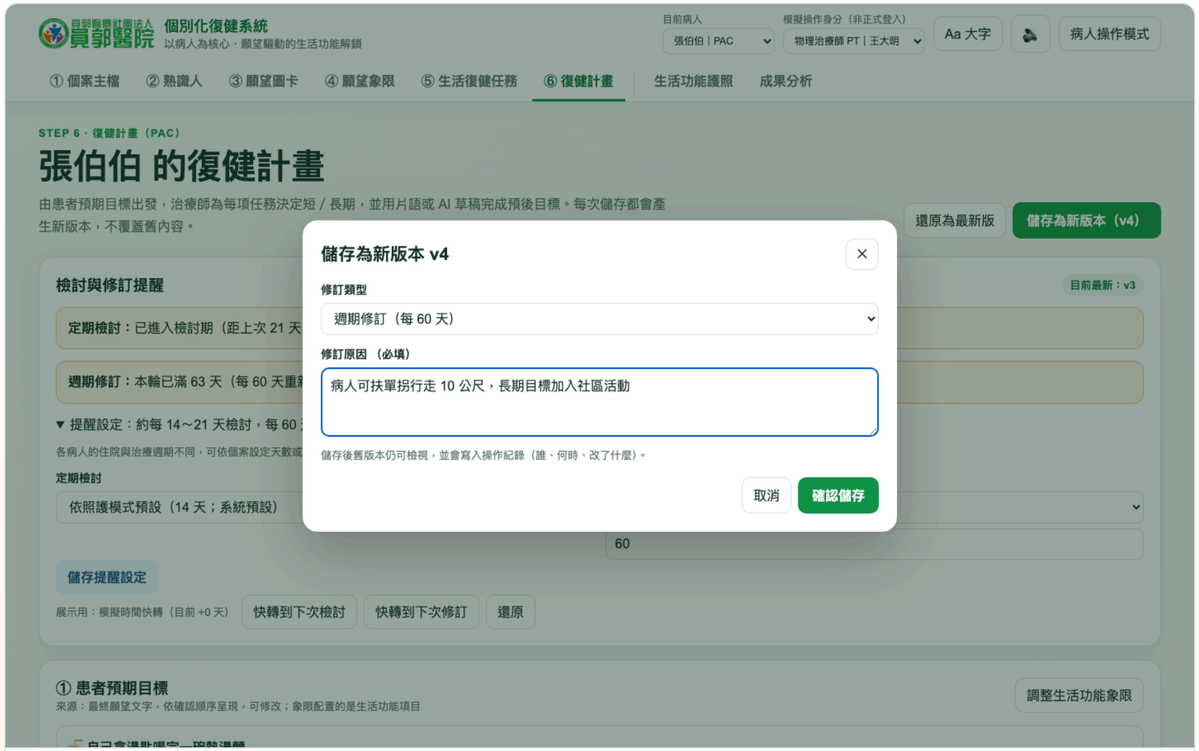


預後目標：預設片語與 AI 草稿（需治療師確認）

AI 草稿標示標籤，專業人員修改後才儲存

儲存新版本與版本歷程

修訂原因必填，v1、v2、v3 皆保留



儲存為新版本：必填修訂原因



版本歷程：v1、v2、v3 皆保留

每次儲存都是新版本，修訂原因必填

階段 ⑥　計畫與追蹤

每次儲存都是新版本

舊版本不會消失；系統依個案設定的天數或日期提醒修訂



追蹤機制



版本比較：標示「已變更」

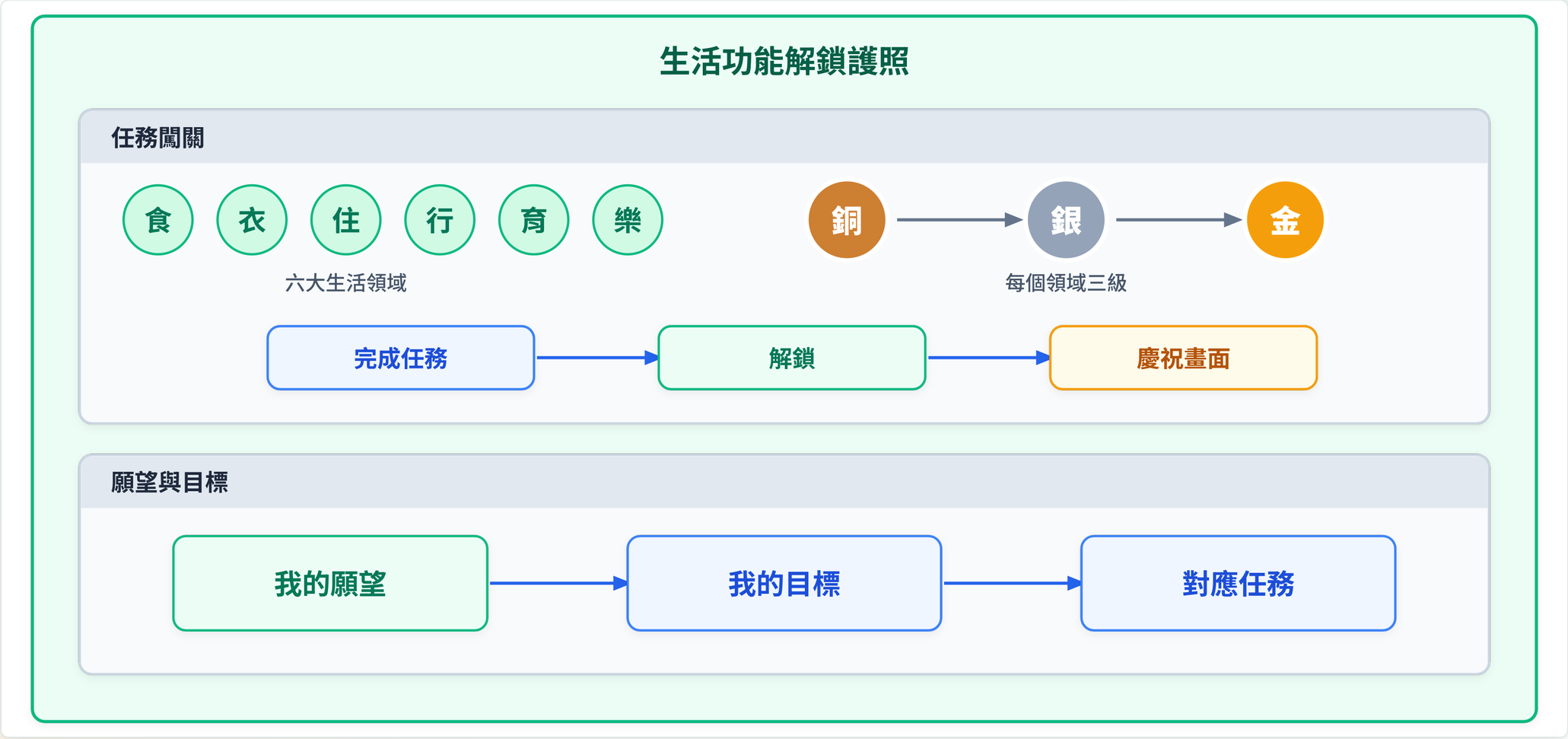
可檢視各版本內容與差異



每次儲存都是新版本，舊版不消失，差異一目了然

生活功能解鎖護照

階段 ⑥ 之後，病人拿到自己的護照，貫穿住院期間直到出院



病人端　系統畫面

生活功能護照：願望、目標與任務

病人與家屬看同一份資料，進度一目了然



護照首頁：進度、獎盃櫃與成就徽章



我的願望與目標：每個願望對應的生活任務



點任務卡：更新狀態與共學夥伴

150 項任務連到病人的願望與目標，進度一目了然

護照對三方的好處

病人、家屬、團隊都看同一份進度

同一份護照資料：願望・目標・任務進度



病人

看得見自己的進步
願意持續練習



家屬

知道病人的目標
知道如何協助



治療團隊

用同一份資料討論
節省溝通時間

出院：成果帶得走

已有的功能先帶走，其餘列入規劃

目前系統已有

- 生活功能護照：解鎖進度與獎盃
- 復健計畫：版本歷程與差異
- 跨專業整合報表

規劃中

- 入院與出院的前後比較
- 願望與目標達成情形
- 居家／社區復健建議

病人轉入一般復健／OPD

主檔與歷程繼續使用

四項品質與安全保障

可追溯、不覆蓋、人為把關、可串接



可追溯

重要操作寫入操作紀錄
誰、何時、做了什麼



不覆蓋

照護模式、熟識人、計畫
皆保留歷史版本



人為把關

AI 只提供草稿
專業人員必須確認



資料串接

預留 HIS、PAC、
杏翔識別碼，可串接

後台管理：操作紀錄

計畫新版本、AI 草稿、照護模式變更、熟識人更新，皆有紀錄



誰、何時、做了什麼，全部可追溯

現況：展示版

目前系統的狀態與後續時程

展示版	資料存在本機瀏覽器；預計 12 月底改用正式資料庫
虛構資料	示範資料皆為虛構
規則式示範	AI 預後目標為規則式示範，尚未接入 AI 模型
尚未串接	串接 PAC 與杏翔排在第二期

後續規劃

時程：從流程確認到場域示範

預計 12 月底系統落地，目標 3/30 前完成 100 個案示範；系統串接排在第二期

① 流程確認 → ② 系統落地 → ③ 場域示範 → ④ 系統串接

現在～11 月	預計 12 月底	預計 1 月～3/30	第二期
確認操作流程 可操作展示版	Server、後端 資料庫上線	100 個案 約 3 個月示範	串接 PAC 與杏翔系統

現在 ——→

成果分析：雷達圖與群體統計

個人看雷達圖，群體看統計；以示範資料即時計算



個人六大領域雷達圖，加上全體病人各領域解鎖、照護模式與願望類別統計

不是多一張表單

讓病人從入院第一天，就說出想回到什麼樣的生活

1

團隊依照病人的願望
訂定計畫

2

每次修訂
都有紀錄

3

出院帶走的不只是病歷
還有自己解鎖的成果

我們希望在主管機關的指導下，把這個模式做得更完整

預期提問與回答

五個常見問題

病人答不出願望怎麼辦？	病人可由家屬協助，團隊可用圖卡引導。 圖卡提供大字模式與大圖書本閱讀
願望不切實際怎麼辦？	願望只是起點。治療師把願望拆成 可達成的短期與長期目標
資料安全如何確保？	展示版只用虛構資料。 正式上線將使用正式 API、資料庫與登入權限
AI 會取代治療師嗎？	不會。AI 只產生草稿， 專業人員必須確認
每種照護模式都要做計畫嗎？	不一定。院方可依照護模式設定： PAC 與復健病房啟用，一般復健與 OPD 為選用